REVISE PARA PROVA · SEU RESUMO EM UMA ÚNICA FOLHA

Obesidade

Diagnóstico, remédios (ABESO 2026), cirurgia bariátrica e complicações em uma página

MAIS COBRADO · 1º IMC + cintura · 2º **Semaglutida e tirzepatida**: alta potência · 3º **Indicação de bariátrica** · 4º **Complicações**: fístula, TEV, Petersen

1 Diagnóstico

IMC é populacional: some cintura e composição corporal

IMC (kg/m²)	Classe	Risco
25–29,9	Sobrepeso	Aumentado
30–34,9	Obesidade I	Moderado
35–39,9	Obesidade II	Grave
≥ 40	Obesidade III (≥ 50 superobesidade)	Muito grave

Circunferência abdominal: risco aumentado **H ≥ 94 · M ≥ 80 cm**; muito aumentado **H ≥ 102 · M ≥ 88 cm**. Relação cintura/altura > **0,5**. A gordura visceral prediz risco independente do IMC.

ABESO 2026: pelo peso máximo (IMC 30–39,9: < 5% inalterada · 5–9,9% reduzida · ≥ 10% controlada) e **Lancet**: obesidade **clínica** (≥ 1 de 18 disfunções de órgão) × **pré-clínica**. Sarcopênica: força baixa + massa magra baixa + gordura alta.

Brasil: > 60% com excesso de peso, ~28% com obesidade (3× em 4 décadas). Causa multifatorial: balanço energético positivo, genética poligênica, ultraprocessados, emoção, remédios.

2 Tratamento clínico

remédio sem mudança de estilo de vida não se sustenta

Pilares: dieta com déficit sustentável, atividade física, **TCC**. **GLP-1:** insulina glicose-dependente, menos glucagon, esvaziamento gástrico lento, saciedade no hipotálamo. Efeitos: GI na titulação. **Contraindicação:** carcinoma medular de tireoide ou NEM 2 (pessoal ou familiar).

Alta potência (≥ 10%): **semaglutida 2,4 mg/sem** (reduz risco CV sem diabetes, ICFEp, MASH, artrose, DRC) · **tirzepatida 15 mg/sem** (MASH, ICFEp, apneia). **4–9,9%:** liraglutida 3 mg/dia, naltrexona + bupropiona, sibutramina (não usar com DCV). **< 4%:** orlistate 120 mg 3×/dia (lipase; esteatorreia).

3 Cirurgia bariátrica

18–65 anos, falha do tratamento clínico

Indicação: IMC **≥ 40** · **≥ 35** + comorbidade grave (DM2, HAS, apneia, dislipidemia, esteato-hepatite) · **30–34,9** com DM2 refratário (metabólica). **Contraindicações:** álcool ou drogas ativos, psiquiátrico grave descompensado, não aderir ao seguimento, doença terminal, ASA IV.

Restritivas: banda (reversível, reoperação) e balão (ponte). **Disabsortiva:** Scopinaro. **Mistas: sleeve** (80% do estômago, tira o fundo e a **grelina**) · **bypass em Y de Roux** (pouch 30 mL, **GLP-1 e PYY** altos, DM2 melhora antes de perder peso) · **duodenal switch** (maior perda e maior risco nutricional).

4 Complicações

Precoces: fístula (sleeve: ângulo de His) com **taquicardia persistente**, febre, dor · sangramento · **TEV**: principal causa de morte precoce (deambular cedo, compressão pneumática, HBPM).

Tardias: deficiência de ferro, B12, folato, cálcio, vit. D (suplementar para sempre) · **dumping** · **hérnia de Petersen** (cólica intermitente; TC falso-negativa em até 20%: explorar) · colelitíase (ursodesoxicólico 6 meses) · **úlcera marginal** (tabaco, AINE; IBP) · reganho.

Não confunda na prova

Os distratores que mais derrubam

1. **IMC normal** não exclui risco: meça a cintura.
2. **IMC ≥ 40** opera mesmo sem comorbidade.
3. **IMC 30–34,9** só com DM2 refratário (metabólica).
4. **Sleeve** reduz grelina; **bypass** sobe GLP-1 e PYY.
5. **Duodenal switch** perde mais e dá mais deficiência.
6. **Taquicardia sem explicação** no pós-operatório: fístula até prova em contrário.
7. **TEV** mata mais que fístula no pós-operatório precoce.
8. **Dor em cólica após bypass**: Petersen, mesmo com TC normal.
9. **Úlcera marginal**: pergunte por cigarro e AINE.
10. **GLP-1 não** em quem tem história de carcinoma medular ou NEM 2.
11. **Sibutramina** é contraindicada na doença cardiovascular.

Números que caem

Cintura **94/80** e **102/88 cm** · cintura/altura > **0,5**
Bariátrica: **40** · **35** + comorbidade · **30** com DM2
Sleeve: **80%** do estômago, vela **32 Fr** · pouch **30 mL**